

專業治療

- 1. 骨水泥手術 | 椎體成形術與椎體撐開術
- 2. 微創腰椎手術 | 內視鏡/顯微減壓與固定融合
- 3. 微創頸椎手術 | 人工椎間盤置換與微創融合
- 4. 腕隧道神經鬆解術 | 正中神經減壓治療
- 5. 神經阻斷及疼痛介入治療 | 精準注射與疼痛控制
- 6. 骨質疏鬆與骨折風險治療 | 骨密度管理與藥物治療

骨水泥手術 | 椎體成形術與椎體撐開術

透過針孔大小的微創傷口，穩定骨折椎體，幫助長輩減少疼痛、重新站起來。

當脊椎因骨質疏鬆、跌倒或外傷發生壓迫性骨折時，最讓人害怕的不是影像上看到一節骨頭塌陷，而是痛到無法翻身、起床、站立，甚至因此長期臥床。

更需要注意的是，如果骨折持續塌陷、骨折處不穩定，或骨折碎片往神經管方向移位，就可能壓迫神經或脊髓，造成腳麻、腳無力、走路困難；嚴重時甚至有癱瘓風險。

對許多脊椎壓迫性骨折患者來說，微創骨水泥手術是一種幫助穩定骨折椎體、減少疼痛、恢復活動能力的治療方式。

治療重點不是單純「灌骨水泥」，而是透過影像導引，精準判斷骨折位置、塌陷程度與神經安全性，再選擇最適合的修復方式。

精準判斷、穩定骨折、重建支撐，幫助患者安全回到生活。

骨水泥手術有哪些方式？

骨水泥手術不是只有一種。

會依照椎體塌陷程度、骨折型態、疼痛時間、骨質條件與生活需求，選擇適合的治療方式。

1. 微創骨水泥椎體成形術

這是最常見的骨水泥手術方式。

醫師會在 X 光影像導引下，經由背部極小傷口，將醫療用骨水泥注入骨折椎體內。

骨水泥硬化後，可以幫助穩定骨折處，減少因骨折微動所造成的疼痛。

適合情況包括：

- 新鮮脊椎壓迫性骨折
- 疼痛位置與影像骨折位置相符
- 椎體塌陷程度較單純
- 保守治療後疼痛改善有限
- 痛到影響翻身、起床或走路

2. 氣囊椎體撐開術

氣囊撐開術是在注入骨水泥前，先將特製氣囊放入塌陷椎體內，慢慢撐開椎體，建立出空間後再填入骨水泥。

這種方式除了穩定骨折，也有機會改善部分椎體高度，並降低骨水泥直接高壓灌注時的滲漏風險。

3. 脊椎千斤頂椎體撐開術

脊椎千斤頂是針對椎體塌陷較明顯、結構支撐需求較高的患者所使用的進階微創治療方式。

和氣囊撐開術相比，氣囊是「撐開後取出，再填入骨水泥」；千斤頂則是「撐開後留下支架，再填入骨水泥」。

因此，對於椎體塌陷較明顯、希望重建高度與支撐結構的患者，脊椎千斤頂在椎體高度恢復、局部駝背角度改善與結構支撐上，通常比單純氣囊撐開更有優勢。

相較於一般骨水泥或氣囊撐開，脊椎千斤頂的特色包括：

- 撐開後保留內部支撐結構
- 較能維持撐開後的椎體高度
- 有助於改善局部駝背角度
- 提供較好的椎體內部支撐
- 適合塌陷較明顯、需要高度與結構重建的患者

簡單來說：

骨水泥，是穩定骨折。

氣囊，是先撐開再填補。

千斤頂，是撐開後留下支撐，再加強穩定。

骨水泥術式快速比較

比較項目	微創骨水泥椎體成形術	氣囊椎體撐開術	脊椎千斤頂椎體撐開術
治療概念	骨水泥直接注入，穩定骨	氣囊撐開後，再填入骨	撐開後留下支架，再填入骨
支撐方式	骨水泥固定	骨水泥固定，並建立空	內部支架加骨水泥支撐
椎體高度改善	以穩定止痛為主	有機會部分改善高度	高度恢復與維持支撐較有優勢
局部駝背矯正	幫助有限	可部分改善	較適合需要角度矯正與結構重建者
適合對象	輕度至中度塌陷、新鮮骨折	中度塌陷、希望降低滲漏風險者	塌陷明顯、結構支撐需求較高者
傷口大小	約針孔大小傷口	小傷口微創方式	小傷口微創方式
費用概念	符合條件可評估健保給付或自費材料	多屬自費醫材	多屬自費醫材，依使用系統與節數而異

實際費用仍需依照醫院收費、健保條件、使用材料與治療節數評估。

骨水泥手術的優點

骨水泥手術最大的價值，是在適合的患者身上，幫助減少疼痛、穩定骨折，讓患者有機會早一點恢復活動。

常見優點包括：

- 傷口小：通常透過針孔或小傷口完成，對肌肉與組織破壞較少
- 疼痛改善快：穩定骨折後，可減少骨折微動造成的劇烈疼痛
- 多數不需全身麻醉：部分患者可在局部麻醉或輕度鎮靜下完成
- 恢復較快：多數患者術後可在醫師評估下，於隔日出院
- 降低臥床風險：避免因長期臥床造成肌力下降、肺炎、血栓或生活功能退化

對高齡長輩來說，治療重點不只是止痛，而是避免因為疼痛而長期躺床，失去原本的行動能力。

如果長輩已經痛到無法翻身、起床或走路，就不要只是一直忍耐。
讓專業醫師協助您判斷，才能選擇最適合的治療方式。

手術不是目的，重新回到生活才是目的。

把時間留給生活，不留給疼痛。